

Mieux vivre la Réanimation

Méthodologie, Q1-5 (barrières, environnement, soins, communication, décision) & sources



Résumé : la réanimation est un lieu de vie mais aussi une agression — pour les patients, les familles et les soignants. Cette conférence de consensus propose des recommandations sur 5 thématiques : les barrières au « mieux vivre », l'amélioration de l'environnement, les soins qui favorisent le mieux vivre, les stratégies de communication, et la personnalisation du processus décisionnel.

Méthodologie — locutions modales (pas de grille GRADE imprimée)

Méthode inspirée de GRADE mais sans symboles imprimés — la force est portée par le verbe modal du texte lui-même : « **il faut** » / « **il ne faut pas** » (recommandation forte) ; « **il faut probablement** » / « **il ne faut probablement pas** » (recommandation jugée importante mais plus discutable) ; « **il est...** » (constat soutenu par des preuves robustes) ; « **il est possible** » (constat moins robuste). Le sigle **RC** (recommandation consensuelle) marque les énoncés du jury sans référence scientifique majeure — repris tel quel dans cette fiche, sans chip numérique inventé.

Q1. Barrières au « mieux vivre » (constats)

Population	Constats principaux
Patient	Bruit (1re source d'inconfort citée — seuil OMS 45 dB le jour/35 dB la nuit, alarmes souvent > 80 dB), lumière (absence d'éclairage naturel), manque de sommeil (2 patients/3), douleur (1 patient/2 — favorise delirium et état de stress post-traumatique [ESPT]), isolement, contention physique. Le delirium touche 1 patient/3 et augmente durée de séjour et morbidité.
Familles	Anxiété et dépression fréquentes ; 1 famille/2 comprend mal diagnostic/pronostic/traitement (facteurs : entretien < 10 min, absence de livret d'accueil). ESPT chez 1 famille/3 (facteurs : information incomplète, implication décisionnelle, décès du proche). Charge financière et logistique souvent sous-estimée — recours à une assistante sociale à proposer précocement.
Soignants	Épuisement professionnel (burn-out) chez 1 médecin réanimateur/2 et 1 infirmier(e)/3 — associé à une moins bonne qualité des soins et plus d'absentéisme. Facteurs communs au burn-out et à l'ESPT : stress, jeune âge, conflits, charge de travail, fin de vie. Les soins de « mieux vivre » sont insuffisamment valorisés et considérés comme non prioritaires.

Q2. Comment améliorer l'environnement ?

Thème	Recommandations
Bruit	<i>Il faut</i> réduire le niveau de bruit, toujours excessif en réanimation. Mesurer le niveau sonore possible. Moduler l'intensité des alarmes, utiliser des répéteurs d'alarme (RC). Politique systématique de réduction du bruit et sensibilisation des soignants (RC). Tenir compte du bruit pour le choix des appareils/matériaux et le positionnement des salles (RC).
Lumière	<i>Il faut</i> favoriser l'alternance jour/nuit. Intensité modulable (RC). Favoriser les écrans de veille des moniteurs/ventilateurs. Chambres et locaux de travail bénéficiant de lumière naturelle (législation).
Personnalisation de la chambre	<i>Il faut</i> une chambre particulière (intimité, confidentialité, participation des familles). <i>Il est possible</i> que l'affichage de photos du patient influence positivement les soignants. Espaces de rangement à la vue du patient. Heure et date visibles (RC).
Organisation des soins	<i>Il faut</i> organiser les soins pour diminuer les sources d'inconfort et adapter les procédures à l'état clinique/souhaits du patient. Rechercher les causes du manque de sommeil (RC). Contention physique tolérée seulement si sécurité en jeu, prescrite quotidiennement (HAS), minimale, ne se substituant pas aux mesures d'apaisement (RC). <i>Il faut</i> favoriser l'informatisation des services (enregistrement automatique des paramètres).
Famille	Sous réserve des soins et de la volonté du patient, <i>il faut</i> une présence des proches sans restriction d'horaires. Présence des enfants facilitée et encadrée — droit reconnu (charte de l'enfant hospitalisé). Liberté d'accès sans risque septique ni perte de qualité des soins démontrés. Pas de protection vestimentaire systématique justifiée scientifiquement. Accès aux représentants du culte à favoriser.

Mieux vivre la Réanimation

Méthodologie, Q1-5 (barrières, environnement, soins, communication, décision) & sources



Q3. Quels soins permettent le « mieux vivre » ?

Thème	Recommandations
Intimité	Rideaux/moyens d'isolement visuel et pancartes signalétiques utilisables pour améliorer l'intimité — souhait majeur des patients et familles.
Kinésithérapie et réhabilitation précoce	Mobilisation possible et sûre dès les premiers jours, associée à une stimulation des gestes de la vie quotidienne (accélère le retour à la marche, raccourcit ventilation/séjour, diminue les états confusionnels). <i>Il faut</i> mettre en place un programme de réhabilitation précoce, suivant les recommandations SKR-SRLF.
Massages	<i>Il est possible</i> d'utiliser les massages (dos, pieds) à visée anxiolytique et antalgique, en particulier après chirurgie majeure.
Musique	<i>Il est possible</i> de faire écouter de la musique pour diminuer l'anxiété (20-30 min, calme/relaxante par défaut, écouteurs individuels, choix laissé au patient). Bénéfice à long terme non étudié.
Hydratation	La soif est une plainte très fréquente (opioïdes, respiration bouche ouverte). Hors contre-indication absolue, <i>il faut probablement</i> dépister et traiter la soif par liquides clairs.
Anxiété et dépression	Prévenues/améliorées surtout par les mesures non pharmacologiques. Fortes doses de benzodiazépines (BZD) nuisent au sommeil et favorisent l'ESPT. <i>Il est possible</i> de diminuer les doses de BZD sédatives sans majorer anxiété/ESPT. Avis spécialisé prudent pour les antidépresseurs (non évalués en réanimation) ; <i>il est possible</i> d'utiliser de faibles doses de BZD si un traitement anxiolytique est nécessaire.
Douleur et agitation	<i>Il faut</i> dépister systématiquement douleur et agitation et les traiter, sans retard pharmacologique. Scores d'agitation/douleur (ex. Behaviour Pain Score) et de délirium (RASS, CAM-ICU) utiles pour guider et limiter les doses de neuroleptiques. <i>Il faut probablement</i> dépister conjointement douleur et agitation par des scores spécifiques. Aspirations trachéales systématiques sans avantage vs guidées par la clinique — <i>il faut probablement</i> éviter les aspirations systématiques.
Soins centrés sur la famille	Présence accrue des familles possible, souhaitable et bénéfique ; participation possible à certains soins (massages, soins oculaires, repositionnements, distractions) — politique de service à définir. <i>Il faut probablement</i> impliquer les familles dans certains soins, notamment en pédiatrie (programmes NIDCAP et COPE : réduisent durée d'hospitalisation, stress parental et risque dépressif ultérieur de l'enfant).

Q4. Quelles stratégies de communication ?

Axe	Recommandations
Soignants-patient	Contact verbal permanent, y compris chez le patient sédaté ; éviter le « on » et le tutoiement (RC) ; découvrir la personnalité du patient (RC). Outils adaptés : lecture labiale, questions oui/non en entonnoir, pictogrammes, alphabet, assistance à la parole (trachéotomie). <i>Il est possible</i> de mettre en place un journal de bord (patient + famille), qui pourrait prévenir dépression/anxiété.
Soignants-famille	Entretiens structurés précoces et réguliers, dans un lieu d'accueil dédié, par le médecin en présence de l'infirmier(e), durée suffisante. Livret d'accueil remis au premier entretien. Identifier la personne de confiance/référente et les directives anticipées. Information claire, loyale, accessible ; transcrite au dossier. Avertir lors d'événements inhabituels et de la sortie. Interprète et durée d'entretien allongée pour les familles non francophones. Annonce d'une mauvaise nouvelle = entretien structuré. <i>Il faut</i> que le médecin soit disponible pour permettre un temps d'information adéquat. Aide spirituelle si besoin ; psychologue si déni de réalité (RC).
Entre soignants	Dossier de soins = outil de communication (transmissions ciblées). <i>Il est possible</i> d'établir une fiche de liaison journalière. <i>Il faut</i> repérer le syndrome d'épuisement professionnel (50 % médecins, 30 % infirmiers) ; sa prévention repose sur le respect mutuel et l'écoute (RC). Groupes de parole (RC) et réunions de service organisées.
Famille-patient	Aide à la communication à proposer aux familles ; communication par le toucher en l'absence de verbal ; peau à peau chez le nourrisson. <i>Il est possible</i> de proposer aux proches de participer aux soins (oculaires, bouche, hydratation des lèvres, toilette), avec formation et accord du patient.

Mieux vivre la Réanimation

Méthodologie, Q1-5 (barrières, environnement, soins, communication, décision) & sources



Axe	Recommandations
Sortie du patient	Moment difficile pouvant induire abandon/insécurité — un livret expliquant le service d'accueil peut améliorer le vécu des proches.

Q5. Comment personnaliser un processus décisionnel ?

Volet	Recommandations
Cadre général	Processus décisionnel = procédures diagnostiques, traitements, recherche clinique, limitations thérapeutiques, fin de vie, don d'organes — décisions non figées, actualisées selon l'évolution. Décisions prises dans l'intérêt du patient, tenant compte de sa volonté (code de santé publique).
Le patient	Compétence rarement présente en réanimation (pas de score validé). Diversité socioculturelle à prendre en compte. Directives anticipées et personne de confiance à respecter (loi du 22 avril 2005). Pour le mineur/majeur protégé : consentement du représentant légal, mais information/écoute/participation de l'enfant adaptées à son degré de maturité.
Les proches	Personne référente identifiée en l'absence de personne de confiance désignée — qualité/apptitude à vérifier. L'estimation par les proches de la qualité de vie du patient diverge souvent de celle du patient lui-même. <i>Il faut</i> accompagner les proches (support d'information à l'admission) et respecter un éventuel refus de participer aux décisions.
Équipe et autres acteurs	Démarche collégiale impliquant l'équipe médicale et soignante. Médecin traitant : connaissance des préférences du patient, peut être la personne de confiance. Spécialistes consultants, psychologue, représentants du culte, acteurs sociaux/bénévoles sollicitables en cas d'échec du consensus.
Modèle décisionnel	Passage d'un modèle paternaliste à un processus partagé entre équipe médicale et patient/représentants, aboutissant à une décision consensuelle sous la responsabilité du médecin. <i>Il est possible</i> qu'un accompagnement pas à pas des proches améliore leur participation et leur compétence.
Étapes de personnalisation	(1) En l'absence de directives, ne pas retarder une suppléance vitale. (2) Apprécier la compétence et rechercher les préférences du patient (loi, RC). (3) Patient compétent : informé, décision libre respectée. (4) Patient incompétent : concertation équipe-personne de confiance/autorité parentale/référent/proches (avis consultatif). (5) Mineur : concertation avec l'autorité parentale, consentement du mineur recherché s'il peut l'exprimer. (6) La participation d'un proche au processus augmente le risque de stress post-traumatique — facteurs prédictifs à rechercher, prise en charge à favoriser. (7) Maintenir un « espace d'autonomie » pour les soins de confort même en cas d'incompétence partielle (ex. choix du moment d'un soin).

Sources et avertissement

SFAR/SRLF, « Mieux vivre la Réanimation », 6e Conférence de Consensus (texte long novembre 2009), organisée selon la méthodologie de l'ANAES, avec la participation du GFRUP et de l'Adarpef, Ann Fr Anesth Réanim 29 (2010) 321-330. 175 références bibliographiques dans le texte intégral (non reproduites ici).

Avertissement — document de 2009/2010 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle condense la partie descriptive/épidémiologique du texte source (Question 1) mais reprend l'intégralité des recommandations actionnables des Questions 2 à 5. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/SRLF. Le cadre légal (directives anticipées, personne de confiance) ayant évolué depuis 2009 (notamment la loi Claeys-Leonetti de 2016), se référer aux textes réglementaires actualisés et à un avis spécialisé avant toute décision.